



Titre: "Gale professionnelle chez un ambulancier du SAMU: à propos d'un cas clinique".

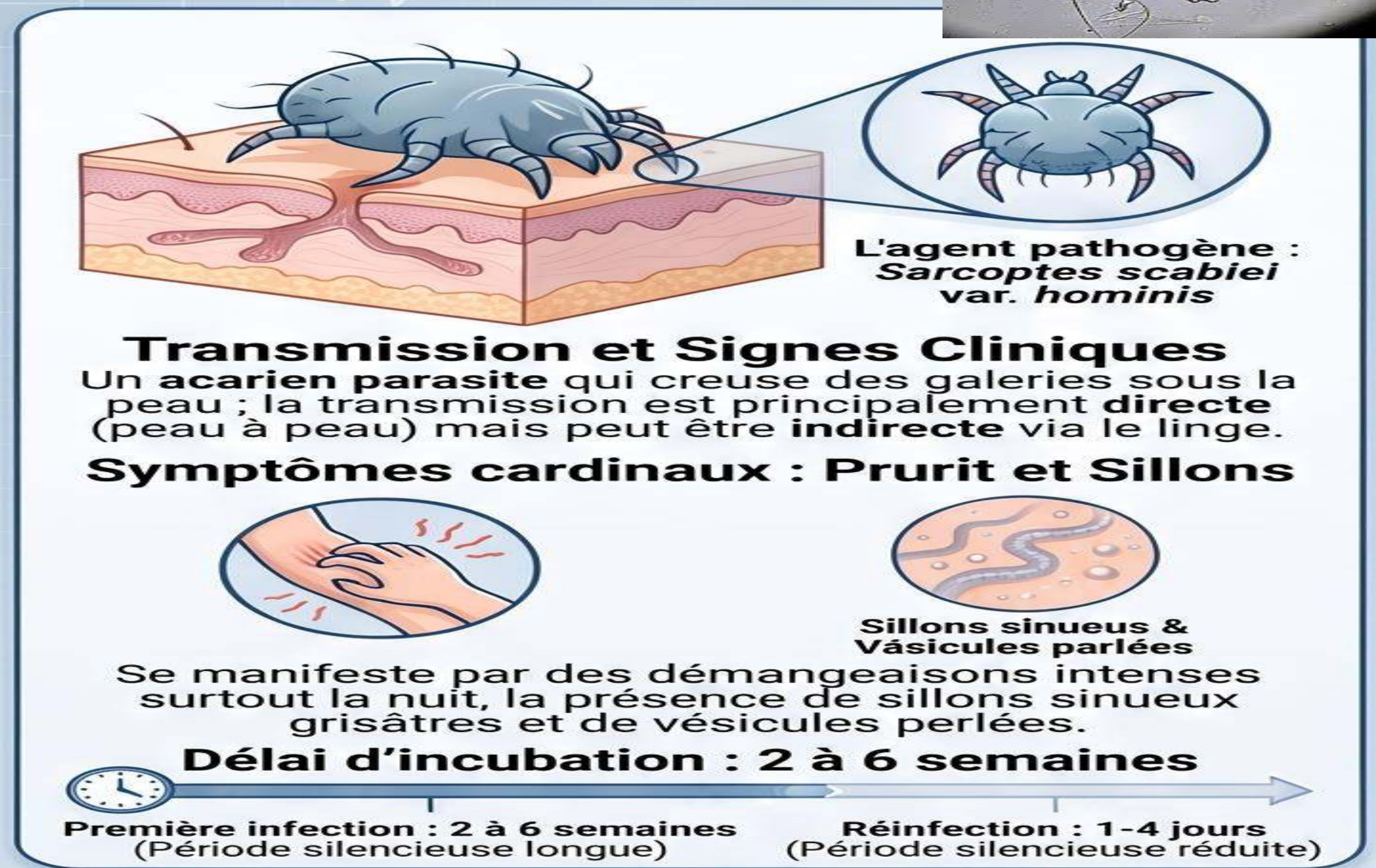
Auteurs: Dr N. Abed, Dr I. Guerfi, Pr C. Idder.
Service médecine du travail CHU Béni Messous- Alger.

1) Introduction:

- La gale humaine est une ectoparasitose contagieuse due à *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*. Sa transmission survient principalement lors de contacts cutanés rapprochés et prolongés, faisant du milieu de soins et des activités de secours préhospitalier des environnements potentiellement à risque.
- Les professionnels du SAMU constituent une population particulièrement exposée en raison de la proximité avec des patients vulnérables, de la diversité des situations d'intervention et de la nécessité de soins ou de manutentions dans des conditions parfois contraignantes.
- Objectif:** illustrer, à travers un cas clinique, les enjeux diagnostiques, médico-professionnels et préventifs de la gale chez un professionnel du secours.



3) les résultats:



4) Discussion:

❖ Prévention:

1. DÉPISTER:

Identifier rapidement les signes évocateurs chez les travailleurs exposés.

2. ÉVALUER:

Analyser les circonstances et la répétitivité des contacts professionnels.

3. PROTÉGER:

Renforcer les mesures d'hygiène et les équipements de protection adaptés aux situations d'exposition.

4. COORDONNER:

Assurer la liaison entre médecine du travail, dermatologie, microbiologie, encadrement et équipes opérationnelles.

5. SURVEILLER:

Rechercher précocement l'apparition de cas secondaires et organiser le suivi des personnels concernés.

6. PRÉVENIR LA RÉCIDIVE:

Mettre en place un retour d'expérience et réévaluer les procédures de prévention lorsque plusieurs cas surviennent.

6) Conclusion:

- La prévention de la gale professionnelle repose moins sur la seule prise en charge du patient que sur la maîtrise de toute la chaîne d'exposition.
- La **détection précoce du cas index et la gestion coordonnée des contacts** constituent les principaux leviers pour éviter l'apparition de cas secondaires et la constitution de foyers au sein des équipes préhospitalières.



2) Matériel et méthode:

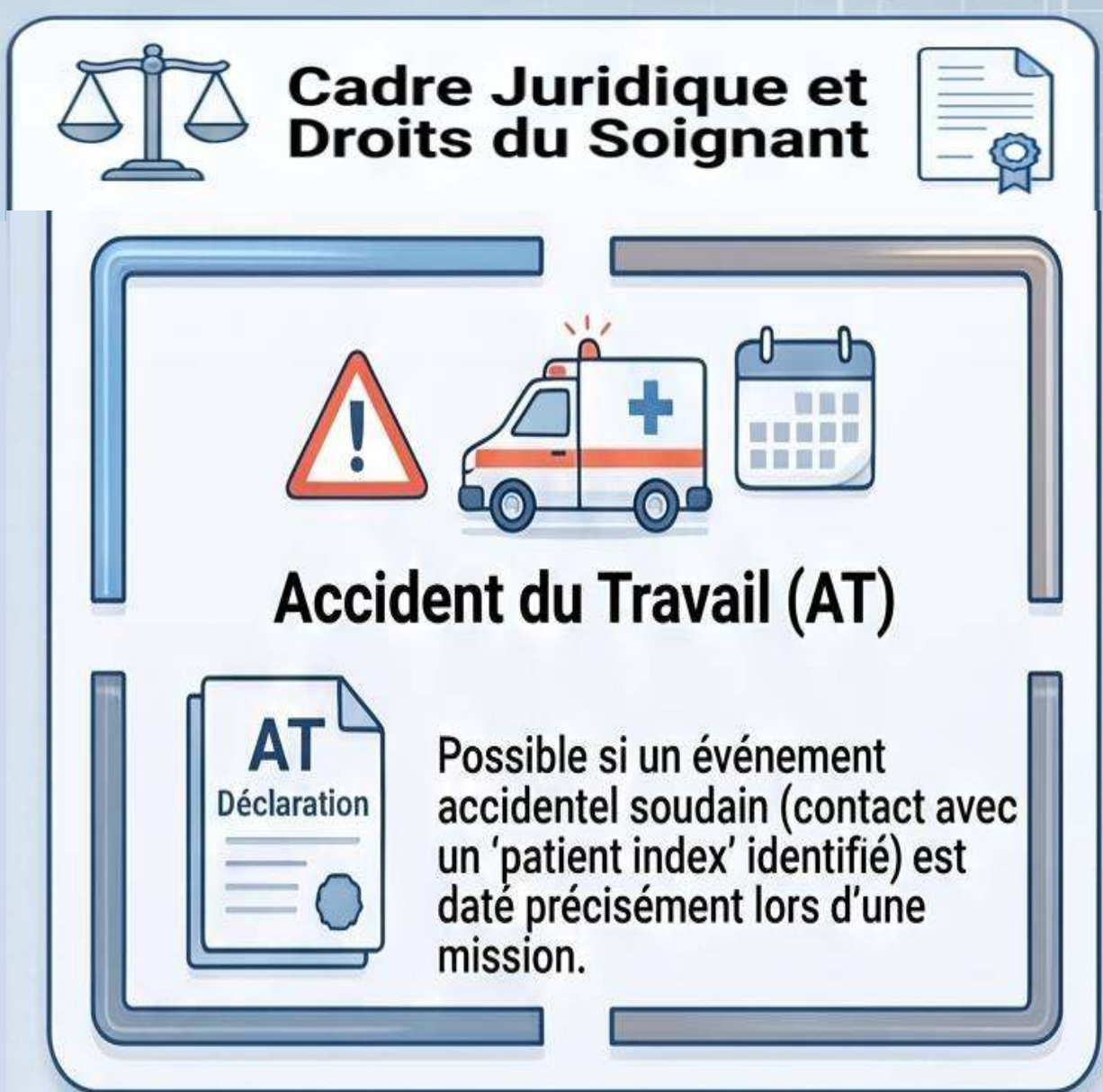
❖ Observation clinique:

Nous rapportons le cas d'un **ambulancier du SAMU âgé de 56 ans**, sans antécédents pathologiques particuliers, consultant en médecine du travail pour un **prurit intense à recrudescence nocturne**, évoluant depuis plusieurs jours.

L'examen dermatologique a objectivé des **lésions excoriées diffuses**, prédominant au niveau des espaces interdigitaux, des poignets et de l'abdomen, associées à des **sillons évocateurs d'une infestation scabieuse**.

❖ Le diagnostic biologique de la gale repose sur:

- La mise en évidence directe du parasite, de ses œufs ou de ses déjections au microscope.
- Le dermoscope** (qui révèle le signe du "delta" correspondant à la partie antérieure du parasite).
- La PCR (Polymerase Chain Reaction)** technique d'amplification d'ADN.



Prévention Individuelle et Protection

Précautions "Contact" obligatoires

Port systématique de **gants à usage unique** et d'une **surblouse à manches longues** pour tout patient suspect ou avéré.



Hygiène des mains post-intervention

Réaliser une **friction hydro-alcoolique** rigoureuse immédiatement après le retrait des équipements de protection individuelle.



Protocole de Désinfection de l'Ambulance

Gestion du linge et de la literie



Isolément 3 jours



Décontamination de la cellule sanitaire



Traçabilité de l'opération

Toute désinfection terminale après un transport infectieux doit être consignée dans le carnet de désinfection du véhicule.